جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : سميحة فتحي شاروبيم كراس

المحافظة : الجيزه　　**الحي / المدينة :** العمرانيه　　**العنوان :** =

رقم البطاقة : 27806102101207　　**رقم التليفون :** 01281644493　　**تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 10-06-1978　　**المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي　　　　**المقر بما فيه**

التوقيع:(--------------------------)　　　　**التوقيع:(--------------------------)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبطات الاروماتيز [14161]　　**قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : --------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني　**الوظيفة:** --------------------------　**التوقيع:** د/ كيلانى

الاسم: د/ندى حسن　**الوظيفة:** --------------------------　**التوقيع:** ندى حسين

الاسم: د/نرمين رمضان　**الوظيفة:** --------------------------　**التوقيع:** نرمين رمضان

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ----------------------　**ا.د/** ----------------------　**د/** ----------------------　**د/** ----------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : --

خطة العلاج : --

المستشفي : --　**قسم :** --

جهة العلاج : --　**نفقات :** --

ملاحظات : --

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

مدير عام
مديرية الشئون الصحية

ختم
شعار الجمهورية

Name: سميحة فتحي شاروبيم كراس
National ID: 27806102101207

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

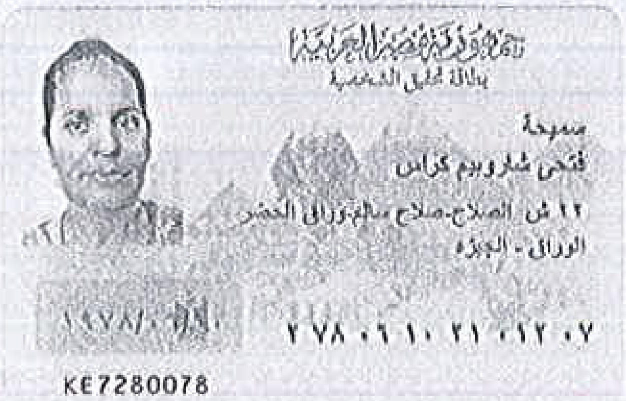
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

مسيحة
فتحي شاروبيم كراس
١٢ ش الصلاح صلاح سالم وراق الحضر
الوراق - الجيزة

١٨٧٨١٠٠٨١

٢٧٨٠٦١١٠٢١٠١٢٠٧

KE7280078

National ID · Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]

٢٧٨٠٦١٠٢١٠١١٠٧ ٢٠٢٣/١٠
ربة منزل
أنثى مسيحية متزوجة
راضي جرجس خليل جرجس
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/١٠/١١

National ID · Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: سميحه فتحي شاروبين جلال **MR. :** 5655	GUSTAVE ROUSSY

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من

بشأن تقرير طبي للمريض

بقسم:

رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :

تاريخ وساعة الخروج :

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 47-year-old with luminal, left-sided breast cancer who has previously received four cycles of AC (doxorubicin and cyclophosphamide) followed by four cycles of TAXOL (paclitaxel). Metastatic disease to bone was identified, and the patient was placed on ARAMIDEX (anastrozole) with supplemental therapy. On the day of evaluation, ZOLADEX (goserelin) was administered for a new assessment in conjunction with cardiac stress testing (CTS) and bone scan (BS). The patient has therefore completed four cycles of AC and four cycles of TAXOL.

A repeat bone scan performed on 26-June-2026 was compared with the scan from November-2025, showing stable sclerotic lesions at L4 and a lytic lesion of benign appearance. Additional imaging on 1-June-2026 confirmed that the sclerotic and lytic lesions have remained stable over six years, suggesting a benign etiology and potential eligibility for surgical intervention. However, the patient has laryngeal problems that preclude general anesthesia, making surgery currently unsuitable. The treatment plan continues with ZOLADEX, ARAMIDEX, and supplemental therapy for an additional three months.

تحريرا في ,

التاريخ : **19-09-2026**

الوقت :

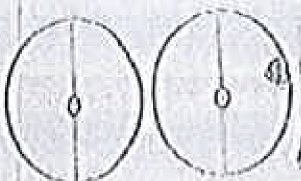
الطبيب المعالج : اسماء محمد مصطفي نصر

يعتمد ,

[illegible] الجمهورية
[illegible] المرأة المصرية

MDT FORM

Name	[illegible]
Age	43 yrs
MRN	1421 [illegible]
ID	
Co. morbidity	Not DM or HTN



ROS

Laparoscopy [illegible]

Biopsy [illegible]

Clinical Data

Dx: IDC G2	SM:
IHC: ER: +ve 8/8 PR: +ve 8/8 Her: [illegible] KI67: [illegible]	Mets Workup: body bone scan sternal & L4 likely mets CTCAP Bone scan [illegible]

T N M

COMMENT: pt received 4 cycles AC + 4 cycles TXL

CTCAP 5/2/22: (1) Reg. course of
ll breast mass 2.7x1.5cm vs 4.8x[illegible]
ll ALNs 2.3x1.5cm vs 3.8[illegible]
(2) sclerotic transformation of the sternal
& L4 lytic osseous lesion (reg)

For further [illegible]

MDT OUTCOME & PLAN

[illegible] the [illegible]
[illegible] CAC + [illegible]

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــحة والسكـان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الأشعة

Patient Name: Samiha Fat'hy Sharobim	Date : 11/12/2022
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 43 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 12761

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

Follow up for a case of breast cancer, as compared to last study dated 06/06/2022.

1. ***Chest:***
   - Stationary course as regards the size of the:
     - Left breast , laterally located skin-attached mass lesion, currently still measures about 2.1 x 1.5 cm.
     - Few prominent left axillary lymph nodes ,largest still measures 1.5 x 0.9 cm.
   - No current sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
   - No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
   - No evidence of pleural effusion.
   - Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
   - Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
2. ***Abdomen and pelvis:***
   - The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities. No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
   - Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
   - Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
   - Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
   - Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular out pouching.
   - Normal appearance of the other pelvic organs.
   - No abdominal or pelvic lymphadenopathy or collections.
   - **Again noted lower uterine contraceptive device.**
   - **Scanned skeletal portions revealed:**
     - **Stationary course of the previously noted Mild Sclerotic transformation** of the previously noted Sternal and L4 lytic osseous lesions.

OPINION:

- ***Follow up post-therapy status showing over-all stationary course as described above.***

Dr. Mohammed Mohsen, MSc

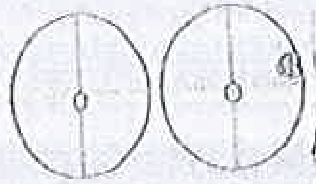
Dr. Amr Farouk, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

[illegible]

MDT FORM

Name	[illegible]
Age	45 yrs
MRN	1491/2021
ID	
Co. morbidity	Not DM or HTN



MOG

11 2018

laryngoscopy [illegible]

biopsy [illegible]

Clinical Data

Dx: IDC G2	SM:
IHC: ER: +ve 8/8 PR: +ve 8/8 HER2: neg KI67: [illegible]	Mets Workup: CT CAP baseline sternal d/l/a likely mets Bone scan [illegible] free

T N M

COMMENT: pt received 4 cycles AC + 4 cycles TXT [illegible]

CT CAP 5/7/22 → ① Reg course of

|| breast mass 2.4×1.5cm vs 4.8×3.5cm

|| ALNs 2.3×1.5cm vs 3.2cm

② sclerotic transformation of the sternal d/l/a lytic osseous lesion (reg)

For further ttt

MDT OUTCOME & PLAN

the Kemot [illegible]

① Bone scan

② [illegible] CAL + Zoledronic

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
[illegible]			

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

[illegible] Number: m6553			[illegible]
		42 Y	[illegible]
Female	النوع		[illegible]
القاهرة	العنوان		[illegible]
02/12/2020 11:46	تاريخ استلام العينة	مركز صحة المرأة	[illegible]
03/12/2020 08:48	تاريخ التقرير	مركز صحة المرأة	

[illegible]ary Sample

[illegible] Block

Test

[illegible]PR & HER2neu & K67 (ER&PR: Harvey scoring system - Her2neu : CAP scoring system)

Comment

Technique

[illegible] recieved was treated by : CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody - CONFIRM anti-[illegible]sterone receptor(PR) (IE2)Rabbit monoclonal primary antibody

[illegible] recieved was treated by : VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection [illegible] Ventana benchmark GX

[illegible] recived was treated by : CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody

Result

[illegible] strong nuclear staining of 60 % of tumour cells
PR : strong nuclear staining of 60 % of tumour cells
[illegible]2/neu protein over expression : discontinuous membrane staining of tumor cells
[illegible] positive nuclear staining of about 30 % of tumour cells

Referral Lab

Comment

[illegible]clusion

[illegible] POSITIVE (SCORE 8 / 8)
[illegible] POSITIVE (SCORE 7 / 8)
[illegible]2 NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : NEGATIVE (SCORE 1+)
[illegible] THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS ABOUT 30 %
[illegible] BIOPSY)

Lab Director: [illegible]

Pathologist [illegible]

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]